

Diretoria de Assistência à Saúde
Gerências de Distritos Sanitários
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial

Nota Orientativa nº 03/2024 – SES.APS

Assunto: Orientações referente ao acesso à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na Atenção Primária pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)

CONSIDERANDO a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), e em seu Art. 2º que “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”;

CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 502, de 27 de maio de 2021, que dispõe sobre o funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), de caráter residencial;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa da Diretora da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (DIVS) nº 003 DIVS/SUV/SES, de 01 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas sujeitas a vigilância sanitária;

CONSIDERANDO que a Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Joinville é formada por 3 distritos (Norte, Centro e Sul), sendo estes subdivididos em 54 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs);

CONSIDERANDO que a comissão de distribuição do acesso é composta pelos seguintes membros: dois coordenadores de cada Distrito, o apoio das Gerências Distritais, o médico representante da APS, um técnico do Núcleo de Gestão Assistencial, um fiscal da Vigilância Sanitária, um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDI) e um representante do Conselho Municipal de Saúde (CMS);

As Gerências de Distritos, por meio da Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, vem orientar as equipes das UBSFs e as Instituições de Longa Permanência sobre a forma de acesso, normativas e responsabilidades de cada órgão envolvido, a fim de promover a prevenção, promoção

e os cuidados em saúde necessários à pessoas idosas institucionalizadas que apresentem algum agravo em saúde.

A comissão de distribuição do acesso realizará a divisão das UBSFs referentes à Atenção à Saúde dos usuários das ILPIs. Esta divisão seguirá os critérios pré-estabelecidos, e a planilha excel será disponibilizada, via drive, no e-mail ilpi.aps.ille@gmail.com.

ACESSO À UBSF DE REFERÊNCIA DA ILPI

As ILPIs acessarão a UBSF de sua referência, por meio de contato do Responsável Técnico da instituição, de forma presencial, informando a instituição que representa, solicitando avaliação e o início do cuidado da pessoa idosa institucionalizada adscrita em seu território, conforme fluxogramas em anexo (anexo 1 e 2).

CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DO ACESSO DAS ILPIs POR UBSFs

Para a realização da distribuição do acesso das ILPIs por UBSF, foram consideradas as necessidades em saúde das pessoas idosas institucionalizadas, a necessidade de efetivação do Plano Terapêutico Singular (PTS) para cada pessoa idosa e a equanimidade entre as pessoas idosas institucionalizadas e aquelas pertencentes ao território. Os critérios utilizados para distribuição do acesso das ILPIs no município de Joinville aos serviços de saúde ofertados nas UBSFs, são os seguintes:

- ✓ tempo de atuação da ILPI no território;
- ✓ número de pessoas idosas institucionalizadas em cada ILPI;
- ✓ número de equipes na UBSF.

PAPEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é responsável por acolher e garantir a proteção integral da pessoa idosa institucionalizada, estando em consonância com o regulamento técnico e definição de normas de funcionamento vigentes na RDC nº 502/2021, do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Conforme a Resolução Normativa da DIVS nº 003/2021, a ILPI é considerada um local de alto risco sanitário, no qual, o responsável técnico da instituição, possui a responsabilidade de aferir pelos cuidados e estar em acordo com as normas vigentes junto a Vigilância Sanitária do município. Assim como, a Secretaria da Saúde é responsável de prestar atendimentos à todas as pessoas residentes nas instituições de longa permanência, bem como a fiscalização em relação aos cuidados prestados aos mesmos.

Cabe a Vigilância Sanitária a fiscalização do cumprimento das normas e recomendações vigentes quanto às adequações físicas e medidas de cuidado em relação às pessoas idosas. Esta fiscalização será efetuada de forma rotineira, por meio de visitas às instituições. Os critérios a serem avaliados estão de acordo com o Sistema de Informação Estadual de Risco e Benefício Potencial (SIERBP). Salientamos que qualquer cidadão pode realizar denúncia por meio de qualquer observação frente à desacordo com as necessidades e cuidados preconizados, através do telefone 156, na Ouvidoria da Prefeitura de Joinville.

CUIDADO COMPARTILHADO ENTRE UBSF E ILPI

O cuidado é compartilhado entre as UBSFs e os profissionais que atuam nas ILPIs, dar-se-á por meio de intervenções dos cuidados integrais à pessoa idosa institucionalizada, salientando que é recomendado à ILPI manter o registro de informações como:

- ✓ histórico vacinal;
- ✓ alergias;
- ✓ história médica pregressa (doenças, hospitalizações, cirurgias, acidentes);
- ✓ histórico de doenças na família;
- ✓ hábitos de vida (profissão, uso de cigarro, bebida alcoólica);
- ✓ doenças atuais, idade aproximada do diagnóstico e do início do tratamento de cada patologia;
- ✓ lista dos medicamentos de uso contínuo e posologia dos mesmos;
- ✓ atenção aos sinais/sintomas de demência, são importantes as informações de quando iniciaram os sintomas, o desenvolvimento da doença e a evolução até o momento da admissão na ILPI;
- ✓ registrar as condições de saúde como: aferição de sinais vitais; sinais e sintomas referidos; peso; altura; entre outros.

Nota: cabe à ILPI a responsabilidade de manter e arquivar os prontuários dos usuários com as informações da saúde da pessoa idosa. Além de fortalecer e garantir o acompanhamento periódico dos familiares, principalmente àquelas com maior grau de dependência.

PLANO TERAPÊUTICO SINGULAR

O cumprimento dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que preza pela igualdade, equidade e universalidade dos serviços ofertados, ocorrerá pelo acompanhamento da equipe de saúde da UBSF de referência, aos residentes em ILPI e deverá ser garantida de forma igualitária a qualquer pessoa idosa domiciliada em residências comuns. O plano terapêutico singular será definido de acordo com a necessidade do usuário, após avaliação compartilhada entre equipe

de saúde da UBSF e responsável técnico da ILPI, contemplando a frequência de consultas e visitas domiciliares.

ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA UBSF

A ILPI receberá visitas periódicas da equipe de saúde da UBSF de sua referência. Em caso da necessidade de atendimento domiciliar, quando solicitada pelo responsável da ILPI, a equipe de saúde realizará a visita conforme atividade programática da UBSF. Esta visita poderá ser executada por qualquer membro da equipe, conforme o grau de complexidade relatado. A visita domiciliar é ofertada aos usuários que possuam impedimento ou dificuldade de acessar a UBSF, como: usuários acamados, cadeirantes ou com outra dificuldade de locomoção.

As pessoas idosas institucionalizadas que não se enquadram nesta situação poderão ser atendidas na própria UBSF de referência, seguindo o protocolo de acesso usual do serviço.

É de responsabilidade da equipe de saúde da UBSF fornecer e completar a Caderneta da Pessoa Idosa para cada morador sob seu cuidado, sendo este o instrumento que qualifica a promoção e a proteção de saúde da pessoa idosa.

No caso de necessidade de consulta de forma emergencial, a coordenação da ILPI deve acionar a família e/ou SAMU, para que providências para este atendimento sejam tomadas em tempo oportuno.

O atendimento médico ou de enfermagem da UBSF à pessoa idosa, seja ele em domicílio, na ILPI ou nas UBSFs, deve ser acompanhado por um familiar ou responsável pela ILPI.

Em caso de renovação periódica de receitas de medicações de uso contínuo, a UBSF responsável deverá programar o atendimento, após solicitação da ILPI, podendo ser agendadas através de teleconsultas online, com antecedência de 15 dias do vencimento das receitas. Estas receitas de uso contínuo devem ter validade máxima de 6 meses.

IMPORTANTE: após identificação da unidade de referência do usuário (conforme fluxograma - anexo 2), deverá ser realizado o cadastramento e vinculação dos usuários.

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NA ILPI

O profissional enfermeiro da UBSF de referência da instituição é o responsável pela supervisão, orientação e execução dos procedimentos técnicos privativos da profissão, realizados na ILPI pela equipe de enfermagem da unidade de saúde, sendo garantido a autonomia deste profissional, em relação à metodologia de supervisão e cuidados acerca dos procedimentos inerentes à esta categoria.

No caso do responsável técnico da ILPI for enfermeiro, este deve conduzir sua atuação de acordo com a legislação pertinente ao exercício profissional da Enfermagem, respeitando a legislação que abrange a população idosa, considerando a RDC nº 502/2021.

A atuação do enfermeiro responsável técnico encontra-se definida no art. 16º da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 727/2023, que institui os procedimentos necessários para concessão, renovação e cancelamento do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Serviço de Enfermagem, e define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico (ERT).

Os procedimentos de enfermagem podem ser realizados pela equipe da ILPI, desde que sejam profissionais de enfermagem e que tenham o registro do conselho responsável pela categoria. Todos os procedimentos de enfermagem devem ser registrados conforme orientações da Resolução COFEN nº 0514/2016.

DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS

A dispensação de materiais e dispositivos necessários para atendimentos e cuidados em saúde, será realizada após avaliação da equipe de Estratégia de Saúde da Família, sendo necessária a prescrição contendo a quantidade. Os insumos serão solicitados e fornecidos pela UBSF de referência, de acordo com os Protocolos vigentes da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), conforme descrito no quadro abaixo (quadro 01).

Quadro 01. Publicação no Processo SEI dos insumos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Insumo	Documento	Processo SEI	Anexo SEI	Data de Publicação
Glicosímetro	Distribuição de Glicosímetros e Tiras Reagentes para Medição de Glicose Sanguínea	23.0.115200-0	-	05/2023
Aspiração / Dieta enteral / Vesical	Insumos	22.0.326269-3	0014411473	09/2022
Fralda	Protocolo de Acesso à Fraldas Descartáveis para uso Domiciliar	23.0.107310-0	0018012914	08/2023
Curativo - Gaze	Procedimento Operacional Padrão (POP) - Rotina nº 22: Prescrição insumos para tratamento de feridas na Atenção Primária	22.0.413807-4	0015255596	12/2022

Fonte: NGA, 2024.

Nota: é de responsabilidade da ILPI, adquirir e fornecer, todos os materiais de consumo da mesma e dos seus usuários, bem como, os equipamentos de Proteção Individual (EPI's).

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

A dispensação de medicamentos ocorrerá nas farmácias de referências das ILPIs, na qual a UBSF terá a garantia de autonomia para organizar a periodicidade e a forma de dispensação dos medicamentos para as instituições. Salientando que esta organização da dispensação às ILPIs não afetará a assistência prestada aos demais usuários do território.

O representante da ILPI deverá levar na Unidade de Saúde as receitas (respeitando um prazo de 5 dias antecedentes a data de vencimento), juntamente com documento de identificação do usuário para o qual será dispensado o medicamento e assinará o protocolo de entrega das receitas com data e hora (anexo 4). Após este processo, a UBSF terá um prazo de até 5 dias úteis para separação e entrega dos medicamentos, sendo que este prazo pode ser maior quando relacionar-se ao pedido de Fórmulas Especiais e Suplementos Alimentares (quadro 02). A critério da UBSF o prazo poderá ser menor, considerando o quantitativo de receitas entregues pela mesma instituição no dia e demanda.

É responsabilidade da ILPI a retirada dos medicamentos na UBSF, sendo obrigatório, que o representante confira e assine o protocolo de entrega, conforme fluxograma em anexo 3.

Quadro 02. Publicação no Processo SEI das Fórmulas Especiais e Suplementos Alimentares fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde

Insumo	Documento	Processo SEI	Anexo SEI	Data de Publicação
Suplemento nutricional via oral para pacientes maiores de 10 anos	Protocolo Resumo 2018 - Fórmulas Especiais e Suplementos Alimentares	21.0.201412-0	0017003089	2018

Fonte: NGA, 2024.

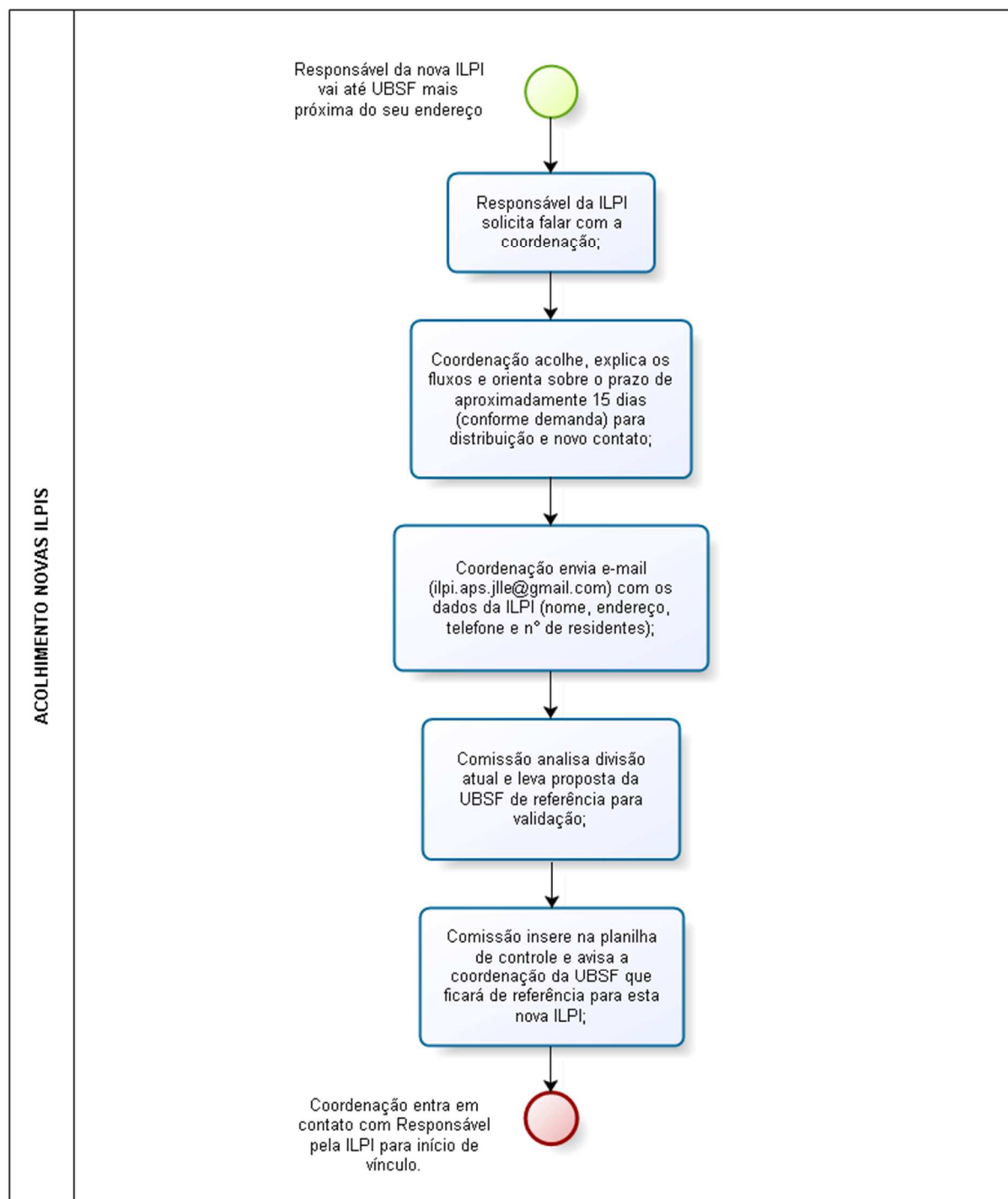
Nota: os medicamentos psicotrópicos são dispensados em farmácias que possuem farmacêutico. A ILPI será orientada pela UBSF de referência sobre o local de retirada destes medicamentos, caso a UBSF de referência não possua o farmacêutico.

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003**. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. Brasília - DF: 2003;
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017**. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Brasília - DF: 2017;
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada. **RDC nº 502, de 27 de maio de 2021**. Dispõe sobre o funcionamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial. Brasília - DF: 2021;
4. SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Sanitária. **Resolução Normativa da DIVE/SC nº 003 DIVS/SUV/SES**. Dispõe sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas sujeitas a vigilância sanitária. Santa Catarina - SC: 2021;
5. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). **Resolução Cofen nº 727/2023**. Institui os procedimentos necessários para concessão, renovação e cancelamento do registro da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Serviço de Enfermagem, e define as atribuições do Enfermeiro Responsável Técnico (ERT). Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-727-de-27-de-setembro-de-2023/>. Brasília – DF: 2023;
6. BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). **Resolução Cofen nº 514/2016**. Aprova o Guia de recomendações para registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de enfermagem. Disponível em: www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05142016_41295.html. Brasília – DF: 2016.

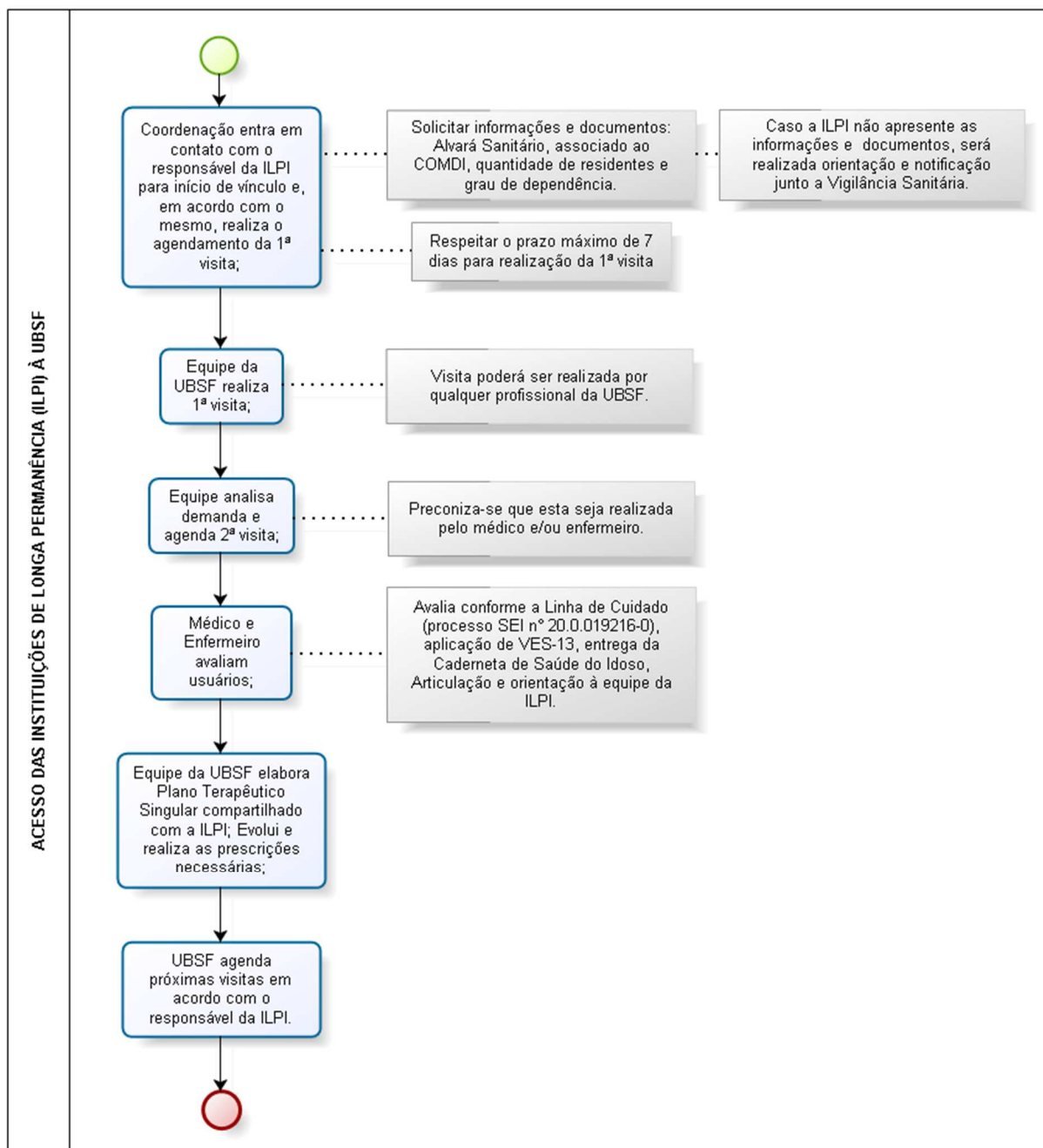


Anexo 1. Fluxograma de Acolhimento das Novas ILPIs



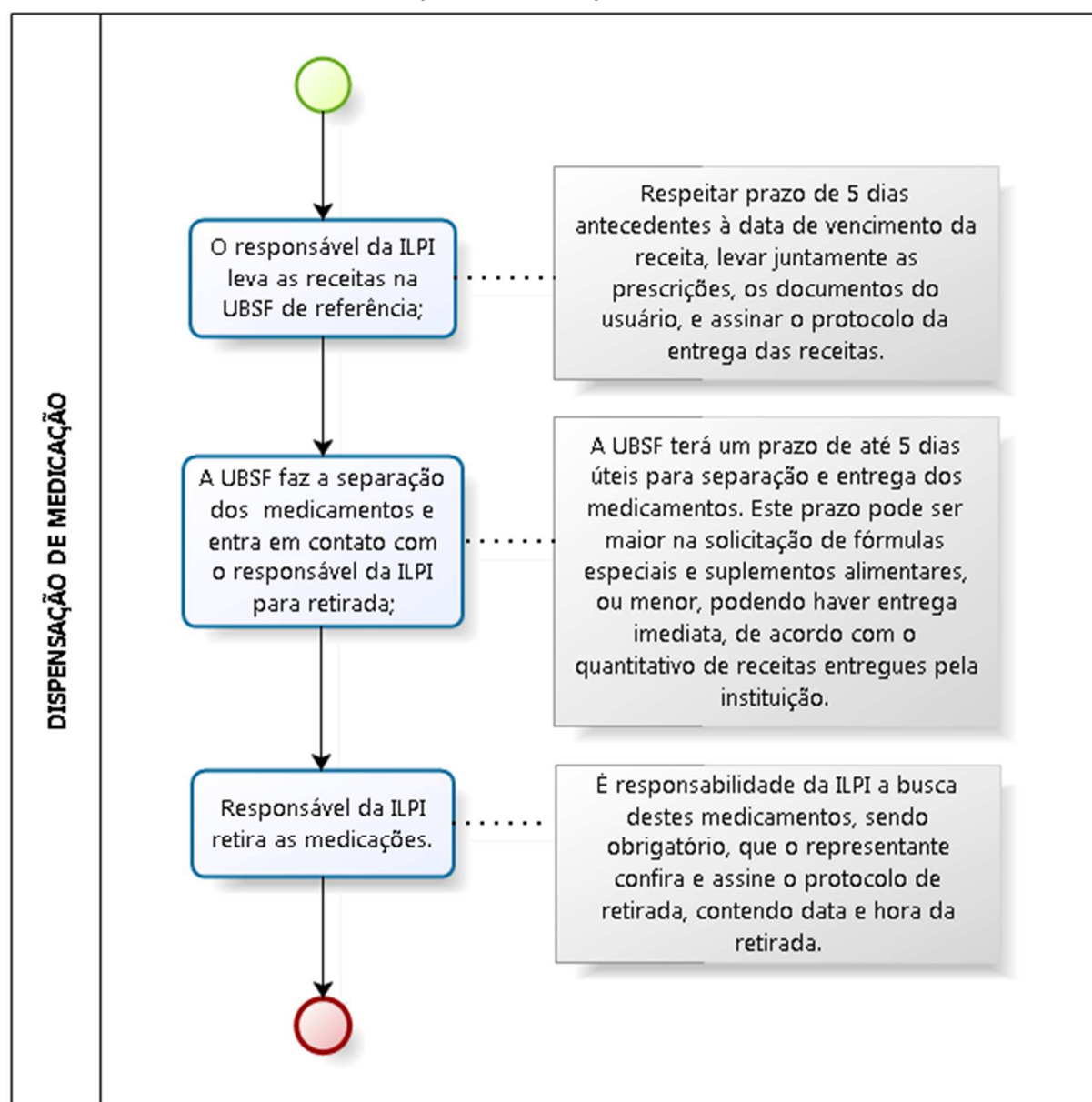
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 2. Fluxograma de acesso das Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPIs) na Unidade Básica de Saúde da Família



Fonte: NGA, 2024.

Anexo 3. Fluxograma de dispensação de medicação



Fonte: NGA, 2024.



Anexo 4. Protocolo de Entrega de Medicamentos

[illegible]

Fonte: NGA, 2024.